جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : توحيده توفيق محمد حموده
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** بولاق الدكرور **العنوان :** بولاق الدكرور
رقم البطاقة : 24604030100607 **رقم التليفون :** 01005605685 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 24-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 03-04-1946 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط ثاني مثبطات الاروماتيز [14161] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: توحيده توفيق محمد حموده
National ID: 24604030100607

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Second Line Hormonal Treatment Aromatase Inhibitor

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

MDT FORM

24/6/2022

Name	تكريمه توفيق محمود	MRN	٢٠٢٢/٤٠٦٠
	76 Year	ID	٢٤٦٠٤٠٣٠١٠٠٦٠
Age		Phone	٠١٠٠٥٦٠٦٦٥
Menopausal status		marital status	
OCP		Familyhistory	
Co morbidity	Cardiac → AF, Hypertension, thyroid disease on medication		

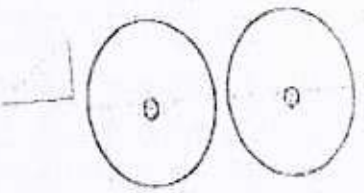
Clinical Data

Bx: mixed IDC & ILC grade II

ER:	PR:	HER2:	KI67:
8/8	8/8	-ve	

Sonomammography: Lt Breast Retro-areolar malignant mass, Lt LNs

R L



Mets Workup: osteolytic metastatic bone lesions (D9-12)

TNM

Recommendations:

MDT OUTCOME & PLAN

for MF dorsal vibe

spine surg + urg + consult

start A-I + zoledronic acid

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
SK		Planning planning	
21/6/2022		21/06/2022	
Angelsalem			
21/6/2022			

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Name: توحيده توفيق محمد حموده	
MR. : 8268	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient has metastatic breast cancer with osseous involvement and is being treated with FEMARA; Zometa was initially planned for bone scan and CT chest/abdomen/pelvis evaluation, and the plan was to proceed with these imaging studies.

The patient continues to have metastatic breast cancer to bone while on FEMARA; the patient is refusing Zometa pending further assessment.

The patient has de novo metastatic breast cancer to bone diagnosed in 2022; a CT chest/abdomen/pelvis is scheduled for today, and FEMARA therapy is planned for a duration of three months.

تحريرا في ,

التاريخ :	19-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : اسماء محمد مصطفي نصر

يعتمد ,

ient Name	:الأستاذه / توحيده توفيق محمد حموده	Request No.	: 13000144
ient No.	:24604030100607	Request Date	: 13/06/2022
n No.	:SR-419/2022	Verification Date	: 21/06/2022
x	:Female	Financial Category	: اورام دار السلام - نقابة الدولة
e	:76 Y	Department	:Out Patient
eferreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	:dr.Enas

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

nical Data:
ft breast cancer
ature of the specimen:
ide revision
ross Examination:
Block (4108/22) + شرائح مكبوره

licroscopic examination:
Histological type: Invasive duct carcinoma and ductal carcinoma in situ with lobular differentiation
Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)

Diagnosis:
Left breast cancer , Slide revision :
• Invasive duct carcinoma grade II and ductal carcinoma in situ with lobular differentiation
• IPT:
- ER: Strong nuclear reaction in about 80% of tumour cells. Positive, score (8/8).
- PR: Moderate nuclear reaction in about 80% of tumour cells. Positive, score (7/8).
- Her-2: No membrane reaction in tumour cells. Negative, score 0
- KI67: 15%

Prof. Dr. Gamal Abd-El Aty
Prof. Dr. Amal Hareedy
Dr.Rana Fathy
Dr. Abdulrahman Ibrahim

Verified by :
abdelrahman ibrahim

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

Patient Name: Tawhida Tawfik Mohamed	Date : 04/06/2022
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 43 Year(s)
Medical ID: 2022/2060	12515

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN, AND PELVIS: -

Findings:

I Chest:-

- Known case of breast cancer showing :
- Bilateral pulmonary mosiac attenuation
- Clear both lung fields. No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Mild cardiomegaly. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & pelvis:

- The liver is mildly enlarged in size with homogenous low attenuation CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
- Gall bladder stones are noted
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

Patient Name: Tawhida Tawfik Mohamed	Date : 04/06/2022
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 43 Year(s)
Medical ID: 2022/2060	12515

- Lytic bony lesion seen involving the d9 vertebra with posterior cortical breaching and convexity seen effacing the anterior subarachnold space flatenning the ventral aspect of the cord
- Another similar yet much small lytic bony lesion at l2 vertebra with reduction in height
- 1st degree degenerative spondylolithesis at l4-5 level

Opinion:

- **Known case of breast cancer showing no definite pulmonary or hepatic metastatic disease**
- **D9 and l2 osteolytic metastatic bony lesion as described**
- **Fatty hepatomegaly with calcular gall bladder**

Dr. M. Gomaa, M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]